

第七次



上海市东方医院南院

出院小结

姓名:曹启迟 性别:男 年龄:55岁 科室:肿瘤科

床号:S2014 住院号:901360

入院日期:2025-11-04

出院日期:2025-11-06

入院诊断:1.左肺上叶恶性肿瘤(腺癌, cT4N3M0 NRAS EXON3突变 PD-L1 (TPS:20%)) 2.腹腔神经鞘瘤

出院诊断:1.左肺上叶恶性肿瘤(腺癌, cT4N3M0 NRAS EXON3突变 PD-L1 (TPS:20%)) 2.腹腔神经鞘瘤

入院情况:

患者因“确诊左肺腺癌4月余”入院。查体: ECOG-PS评分1分, NRS评分1分。神清, 气平, 精神可。皮肤巩膜无黄染。全身浅表淋巴结未及肿大。双肺呼吸音清, 未及明显干湿性啰音, 心率67次/分, 律齐, 未及病理性杂音。全腹平, 未见肠型及胃肠蠕动波。未见腹壁静脉曲张, 全腹触软, 无压痛, 无反跳痛, 无肌卫, 肝脾肋下未及。移动性浊音阴性, 肠鸣音正常, 双下肢无浮肿。四肢肌力正常。

住院期间的辅助检查:

2025-11-04 14:55 本院 急诊C-反应蛋白(CRP)(其它免疫), 急诊血细胞分析(三分类以上): 白细胞计数 $6.88 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 78.4%↑, 淋巴细胞百分比 13.8%↓, 单核细胞百分比 6.9%, 嗜酸性粒细胞百分比 0.7%, 嗜碱性粒细胞百分比 0.2%, 中性粒细胞计数 $5.40 \times 10^9/L$, 淋巴细胞计数 $0.95 \times 10^9/L$ ↓, 单核细胞计数 $0.47 \times 10^9/L$, 嗜酸性粒细胞计数 $0.05 \times 10^9/L$, 红细胞计数 $3.66 \times 10^{12}/L$ ↓, 血红蛋白 111g/L↓, 红细胞压积 34.6%↓, 红细胞平均体积 94.6fL, 平均血红蛋白量 30.3pg, 平均血红蛋白浓度 321g/L, 红细胞分布宽度CV 14%, 血小板计数 $220 \times 10^9/L$, 血小板压积 0.23%, 平均血小板体积 10fL, 血小板分布宽度 16.6fL, 快速C反应蛋白 2.55mg/L, 嗜碱性粒细胞计数 $0.01 \times 10^9/L$; 2025-11-04 15:13 本院 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法), 血清直接胆红素测定(干化学法), 钙测定(干化学法), 血清总胆固醇测定(干化学法), 钾测定(干化学法), 血清胆碱脂酶测定(干化学法), 葡萄糖测定(干化学法), 肌酐测定(干化学法), 血清白蛋白测定(干化学法), 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法), 淀粉酶测定(干化学法), 血清尿酸测定(干化学法), 血清碱性磷酸酶测定(干化学法), 尿素测定(干化学法), 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法), 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法), 血清甘油三酯测定(干化学法), 氯测定(干化学法), 乳酸脱氢酶测定(干化学法), 钠测定(干化学法), 血清脂肪酶测定(干化学法), 血清总胆红素测定(干化学法), 血清总蛋白测定(干化学法), 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法): 尿素 6.2mmol/L, 淀粉酶 96U/L, 血清碳酸氢盐 36mmol/L↑, δ-胆红素 6.3umol/L, 结合胆红素 0.0umol/L, 非结合胆红素 2.1umol/L, 钾 4.0mmol/L, 钠 139mmol/L, 氯 103.0mmol/L, 葡萄糖 10.9mmol/L, 尿酸 380umol/L, 肌酐 57umol/L↓, 丙氨酸氨基转移酶 31U/L, 天门冬氨酸氨基转移酶 38U/L, 碱性磷酸酶 78U/L, γ-谷氨酰转肽酶 62U/L, 乳酸脱氢酶 240U/L, 胆碱酯酶 9809U/L, 总蛋白 67g/L, 白蛋白 40g/L, 总胆红素 8.4umol/L, 钙 2.22mmol/L, 胆固醇 5.95mmol/L↑, 甘油三酯 2.56mmol/L↑, 脂肪酶 118U/L, 高密度脂蛋白 1.02mmol/L↓; 2025-11-04 15:15 本院 急诊各种白介素6(IL-6)测定, 血清肌酸激酶-M



上海市东方医院南院

出院小结

姓名:曹启迟 性别:男 年龄:55岁 科室:肿瘤科

床号:S2014 住院号:901360

B同工酶质量测定,急诊B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定,血清肌红蛋白测定,血清肌钙蛋白T测定(化学发光法),急诊降钙素原检测(化学发光法):B型钠尿肽前体测定 61ng/L,降钙素原 0.096ng/ml ↑,肌钙蛋白-T 0.005ng/ml,肌酸激酶同工酶 0.40ng/ml,肌红蛋白 <21.0ng/ml ↓,白介素6 3.0pg/ml; 2025-11-04 17:21 本院 凝血酶-抗凝血酶III复合物测定(TAT),凝血酶时间测定(TT),抗凝血酶活性测定(AT),D-二聚体测定(D-Dimer),凝血酶原时间测定(PT),活化部分凝血活酶时间测定(APTT),纤维蛋白原测定(FIB),纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP):D-二聚体[cobas] 0.313mg/L FEU,纤维蛋白(原)降解产物[cobas] <2.50ug/ml,抗凝血酶[cobas] 123.0% ↑,凝血酶时间[cobas] 16.4秒,纤维蛋白原[cobas] 4.57g/L ↑,活化部分凝血活酶时间[cobas] 27.6秒,凝血酶原时间[cobas] 9.05秒,国际标准化比值[cobas] 1.01; 2025-11-04 17:21 本院 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定(PIC),凝血酶-抗凝血酶III复合物测定(TAT),组织型纤溶酶原激活物-抑制剂复合物检测,血栓调节蛋白检测(TM):凝血酶-抗凝血酶III复合物 5.38ng/mL ↑,血栓调节蛋白 12.73TU/mL,组织型纤溶酶原激活物-抑制剂复合物 3.90ng/mL,纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物 1.131 μg/mL ↑; 2025-11-05 10:06 本院 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP),糖类抗原CA24-2测定,糖类抗原CA-50测定:糖类抗原CA-50 3.04IU/mL,糖类抗原CA24-2 2.37IU/mL,前列腺酸性磷酸酶 2.78ng/mL ↑; 2025-11-05 13:48 本院 血清甲状腺素(T4)测定,降钙素测定(化学发光法),血清游离甲状腺素(FT4)测定,血清三碘甲状腺原氨酸(T3)测定,甲胎蛋白异质体测定,神经元特异性烯醇化酶测定(NSE),糖类抗原CA-125测定,糖类抗原CA19-9测定,促甲状腺素受体抗体测定,细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法),糖类抗原CA15-3测定,游离前列腺特异性抗原测定(FPSA),总前列腺特异性抗原测定(TPSA),甲胎蛋白测定(AFP),血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定,血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定,糖类抗原CA72-4测定,血清促甲状腺激素测定,鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC),癌胚抗原测定(CEA):癌胚抗原 7.1ng/ml ↑,甲胎蛋白 3.9ng/ml,总前列腺特异性抗原测定 1.33ng/ml,游离前列腺特异性抗原测定 0.35ng/ml,神经元特异性烯醇化酶测定 8.5ng/mL,细胞角蛋白19片段测定 3.0ng/mL,糖类抗原CA-125 17.6U/ml,糖类抗原CA15-3 29.1U/mL ↑,糖类抗原CA19-9 6.8U/ml,糖类抗原CA72-4 2.2U/mL,鳞状上皮细胞癌抗原 1.4ng/mL,促甲状腺激素 1.75 μIU/mL,降钙素 4.45pg/ml,三碘甲状腺原氨酸 1.01 ng/ml,甲状腺素 6.72 μg/dL,游离三碘甲状腺原氨酸 2.9pg/ml,游离甲状腺素 1.21ng/dL,游离/总前列腺特异抗原 26%,甲胎蛋白异质体比值 <5.0%,TSH受体抗体 1.12IU/L,胃泌素释放肽前体 67.1pg/ml,甲胎蛋白异质体L3 <0.6ng/ml; 2025-11-05 13:30 本院 血浆皮质醇测定:皮质醇 7.5ug/dL;

2025-11-04 本院 电脑多导联心电图:正常范围心电图

2025-11-05 本院 PET/CT全身检查:1、左肺恶性肿瘤综合治疗后,FDG代谢环状增高,考虑左肺癌侵及左后胸壁及左侧第3、4后肋,肿块周边仍有肿瘤活性组织存在,左肺门转移淋巴结,左锁骨上小淋巴结肿瘤活性受抑。2、脾胃间隙占位,FDG代谢增高,考虑胃间质瘤可能,周边小淋巴结,请结合临床。3、鼻窦炎;双肺散在慢性炎症后遗;双肺气肿、肺大疱;左肺上叶前段小结节,随诊;纵隔4R炎性淋巴结可能大;主动脉及冠动脉硬化。4、肝内钙化灶或肝内胆管结石;肝囊肿;胆汁淤积可能;前列腺增生伴钙化。5、脊柱退行性变;骨髓反应性增生。



上海市东方医院南院

出院小结

姓名:曹启迟

性别:男

年龄:55岁

科室:肿瘤科

床号:S2014

住院号:901360

诊疗经过:

患者已完成6次免疫+AC方案化疗, PET-CT复查提示原病灶较前缩小, 但仍然有较高肿瘤活性, 建议患者后续行放疗, 同时免疫维持治疗, 完成帕博利珠单抗200mg维持治疗后, 地舒单抗保骨治疗, 予以出院。建议行放疗。

出院情况:

患者病情稳定, 一般情况可, 无特殊不适情况。神清, 气平, 精神可。皮肤巩膜无黄染。全身浅表淋巴结未及肿大。双肺呼吸音清, 未及明显干湿性啰音, 心率81次/分, 律齐, 未及病理性杂音。全腹平, 未见肠型及胃肠蠕动波。未见腹壁静脉曲张, 全腹触软, 无压痛, 无反跳痛, 无肌卫, 肝脾肋下未及。移动性浊音阴性, 肠鸣音正常, 双下肢无浮肿。四肢肌力正常。

出院带药:

/

出院注意事项:

1. 健康教育。
2. 肿瘤科门诊随访; 化疗后如出现发热、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等情况, 及时就诊。
3. 出院后每周复查血常规2次(化疗结束后第4天, 第8天): 若白细胞 $< 3 \times 10^9/L$ 或中性粒细胞计数 $< 1.5 \times 10^9/L$, 及时予重组人粒细胞生长因子治疗; 若血小板 $< 60 \times 10^9/L$, 予以重组人白介素-11或重组人血小板生成素治疗。
4. 每两周复查肝肾功能、电解质、凝血功能指标。
5. 患者出院带药若含皮下注射药物(需冷藏); 如需要在我院门诊注射, 请在出院后门诊挂号(肿瘤内科普通门诊), 由门诊医生开具注射费
6. 上海市肿瘤患者社区卫生服务告知单已发放。

复诊及随访时间:

2025年11月27日, 请提前2-3天通过好大夫平台(详见二维码)联系床位入院复查评价/治疗。

李玮

肿瘤科 副主任医师
上海市东方医院

随访医嘱单

微信扫码, 回家还能问医生

扫码步骤:
1、打开微信, 扫左侧二维码;
2、点击“申请添加医生”, 填写患者信息;
3、将手中的现有病历资料拍照上传;
(未拿到的检查结果, 可在拿到后, 随时补充)

根据您的病情, 建议随访_____个月

*好大夫在线提供链接及技术支持

*本平台是医生利用个人业余时间为患者服务, 与工作无关



上海市东方医院南院

出院小结

姓名:曹启迟 性别:男 年龄:55岁 科室:肿瘤科

床号:S2014 住院号:901360

肿瘤科 李玮副主任医师 门诊时间:

专病门诊(肿瘤科胸部肿瘤专病门诊):周三下午(南院)

专家门诊:周四下午(南院)、周五下午(南院)

复印病历:如需复印住院病历资料,可于出院两周后携相关证明材料至5号门病历复印窗口办理;也可以登录医院公众号进行线上申请,支持自提或顺丰快递,预计自提交申请之日起20个工作日内寄出,如有问题可拨打咨询电话。

相关证明材料要求如下:

(一)申请人为患者本人的,应当提供其有效身份证明;

(二)申请人为患者代理人的,应当提供患者及其代理人的有效身份证明,以及代理人与患者代理关系的法定证明材料和授权委托书;

收费标准:复印费按照A4、B5复印纸每张0.5元收取。

接待地点:5号门病历复印窗口接待时间:周一到周五(国家法定节假日除外)9:00-11:00; 13:00-16:00。

咨询电话:021-38804518*26008。

上海市肿瘤患者社区卫生服务告知单

根据《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知》(沪府办发〔2011〕63号)和市卫生计生委、市发展改革委、市财政局、市人力资源社会保障局和市公安局《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》(沪卫计疾控〔2014〕21号)等文件要求,如肿瘤患者满足以下条件之一(1.本市户籍人员,2.《上海市居住证》持证人员,3.持有《上海市居住证》且积分达到标准分值的持证人员的同住配偶和子女),可在居住地辖区内免费享有下列社区卫生服务:

- 1.建立随访卡,评估患者目前状况、症状、心理状态、生活质量和行为危险因素;
- 2.进行一般治疗、定期复诊、康复、护理和生活方式的指导*; *免费服务范围仅限指导
- 3.转介或告知患者及其家属舒缓照护服务、中医药服务及其他肿瘤相关健康教育活动信息。

在服务方式上,居民或家属可前往社区卫生服务中心或社区卫生服务站,由社区卫生服务中心通过电话随访、上门访视等形式提供相应服务。服务涉及的个人信息按照相关规定予以严格保密。肿瘤患者可通过社区签约获得上述服务,期间可选择放弃接受上述服务。

祝早日康复!

上海市东方医院(南院)

医师签名:金莉

签名时间:2025-11-06 11:41